

# Fístulas — Genitourinarias y Rectovaginales

Información para el paciente · Una conexión anormal que hace que se escapen orina, gases o heces **WARWIKI**

Una fístula es un pequeño túnel anormal entre dos órganos que no deberían estar conectados. En la pelvis puede formarse entre la **vejiga (o el uréter/la uretra) y la vagina** — causando escape continuo de orina — o entre el **recto y la vagina** — permitiendo que pasen gases o heces a través de la vagina. Las fístulas no sanan bien por sí solas, pero se pueden reparar.

## Acerca de esta afección

- **Fístula genitourinaria** (por ejemplo, vesicovaginal) — **escape continuo e incontrolable de orina** por la vagina, de día y de noche.
- **Fístula rectovaginal** — salida de **gases o heces por la vagina**, infecciones repetidas e irritación.

Los síntomas pueden ser angustiantes y hacerla sentir aislada — pero son un problema de "tuberías" con una solución de "tuberías", no un reflejo de nada que usted haya hecho mal.

## Qué la causa

- **Cirugía pélvica o ginecológica** (como una histerectomía) — la causa más común en muchos países
- **El parto** — en especial el trabajo de parto prolongado y obstruido (una causa principal en todo el mundo)
- **Radiación**, enfermedad inflamatoria intestinal, infección o (con menos frecuencia) cáncer

## APRENDA LOS TÉRMINOS

### Fístula

Un túnel anormal que conecta dos órganos.

### Vesicovaginal

Una fístula entre la vejiga y la vagina.

### Rectovaginal

Una fístula entre el recto y la vagina.

### Prueba con colorante

Colocar líquido coloreado en la vejiga/el recto para localizar el escape.

### Cistoscopia

Mirar con una cámara dentro de la vejiga para encontrar la abertura.

### Colgajo de Martius

Un colgajo de tejido que se usa para reforzar una reparación.

### Derivación

Una forma temporal de desviar la orina o las heces mientras se sana.

**¿SE PUEDE ARREGLAR?** Sí — la mayoría de las fístulas se pueden reparar, y muchas personas se curan por completo. A veces una fístula pequeña y reciente se cierra sola con una sonda, pero la mayoría necesita una cirugía planificada. El momento importa: los cirujanos a menudo esperan a que baje la inflamación para que la reparación tenga la mejor probabilidad de éxito.

## Cómo se diagnostica

- Un examen, a menudo con una **prueba con colorante** para localizar el escape
- **Cistoscopia** y estudios de imagen para determinar el tamaño, la ubicación y cualquier causa
- Buscar una afección que contribuya (efectos de la radiación, infección, enfermedad inflamatoria intestinal)

## Cómo se trata

- 1 **Cuidado conservador** — una fístula urinaria pequeña y reciente puede cerrarse con una sonda dejada colocada durante varias semanas.
- 2 **Reparación quirúrgica** — cerrar el túnel por vía vaginal o abdominal, a menudo en capas.
- 3 **Colgajo de tejido** — un tejido sano (como un colgajo de Martius) puede reforzar la reparación, sobre todo después de la radiación.
- 4 **Derivación temporal** — en algunas fístulas rectovaginales, las heces se desvían por un tiempo breve para que la reparación sane.

## Bueno saber

- Proteja la piel y use protectores mientras espera la reparación; su equipo puede ayudarla a sentirse más cómoda.
- Las reparaciones después de la **radiación** son más complejas y por lo general necesitan un colgajo de tejido.
- Puede tener una sonda y una **prueba de cicatrización** antes de retirarla.

### Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o dolor pélvico que empeora
- Signos de infección, o sangrado abundante
- Después de la reparación: la sonda deja de drenar, o el escape regresa

## TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Una fístula es una conexión anormal que causa escape de orina (genitourinaria) o paso de gases/heces por la vagina (rectovaginal).
2. La mayoría se pueden reparar — unas pocas pequeñas se cierran con una sonda, pero la mayoría necesita una cirugía planificada, a veces con un colgajo de tejido.
3. El momento importa; su equipo puede esperar a que baje la inflamación. Informe sobre fiebre, signos de infección o escape que regresa después de la reparación.